

Der Krankenstand-Rechner für den Mittelstand: So beziffern Sie Ihre Fehlzeiten-Kosten und senken sie in 90 Tagen messbar

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Rechenformeln, Branchen-Benchmarks und validierten Messskalen, mit der Sie Ihre Krankenstand-Kosten in Euro beziffern und gezielt senken.

1. Was Ihr Krankenstand wirklich kostet: die Formel zum Selbstrechnen

Die meisten Geschäftsführer kennen ihre Krankenstandsquote in Prozent, aber nicht in Euro. Das ist das eigentliche Problem, denn eine Prozentzahl löst keine Entscheidung aus, ein Eurobetrag schon. Hier ist die Formel, mit der Sie es in fünf Minuten selbst ausrechnen.

Schritt 1: Ermitteln Sie Ihre jährlichen Fehltage. Multiplizieren Sie Ihre Mitarbeiterzahl mit den durchschnittlichen Arbeitsunfähigkeitstagen pro Kopf. Laut DAK-Gesundheitsreport 2025 liegt dieser Wert bei rund 20 AU-Tagen pro Beschäftigtem und Jahr. Ein Betrieb mit 80 Mitarbeitern kommt damit auf etwa 1.600 Fehltage im Jahr.

Schritt 2: Bewerten Sie jeden Fehltag. Setzen Sie nicht nur den Bruttolohn an, sondern die Vollkosten eines Ausfalltages. Eine belastbare Faustregel: Bruttotagesentgelt plus rund 21 Prozent Lohnnebenkosten, plus den Produktivitäts- und Ausfallverlust (Überstunden Dritter, Leiharbeit, Fehler, verschobene Aufträge). In der Praxis liegt der Vollkostenwert je Fehltag zwischen 300 und 450 Euro. Rechnen Sie konservativ mit 350 Euro.

Schritt 3: Multiplizieren. 1.600 Fehltage mal 350 Euro ergeben 560.000 Euro pro Jahr. Das ist keine Schätzung ins Blaue, das ist Ihre reale Belastung. Senken Sie die Quote nur um zwei Prozentpunkte, sind das bei diesem Beispiel über 200.000 Euro, die direkt im Ergebnis landen. Diese eine Rechnung verändert erfahrungsgemäß, wie ernst das Thema im Betrieb genommen wird.

2. Ihre vier echten Kostentreiber, mit Benchmarks zum Vergleichen

Krankenstand ist kein Block, sondern setzt sich aus vier Treibern zusammen, die Sie getrennt betrachten müssen, weil jeder anders zu senken ist. Wer pauschal 'die Gesundheit fördern' will, verbrennt Geld. Wer den dominanten Treiber kennt, trifft.

Treiber 1: Muskel-Skelett-Erkrankungen. Sie sind laut DAK 2025 mit rund 22 Prozent der Fehltage der größte Einzelblock, vor allem in Produktion, Logistik und Handwerk. Benchmark: liegt Ihr Anteil deutlich darüber, ist das ein Hinweis auf Arbeitsplatzergonomie und Schwerlastprozesse.

Treiber 2: Psychische Erkrankungen. Mit etwa 18 Prozent der Fehltage der am schnellsten wachsende Block, und mit durchschnittlich über 30 Tagen je Fall der teuerste pro Vorgang. Hier entscheidet Führungskultur und Belastungssteuerung, nicht der Obstkorb.

Treiber 3: Atemwegsinfekte. Hoher Anteil an Fällen, aber kurze Dauer, stark saisonal. Benchmark: wenn Sie hier auffällig liegen, ist meist Präsentismus das eigentliche Thema, also Mitarbeiter, die

krank zur Arbeit kommen und andere anstecken.

Treiber 4: Langzeitfälle über sechs Wochen. Sie machen oft unter fünf Prozent der Fälle aus, aber bis zu 40 Prozent der Fehltag. Hier liegt der größte Hebel und gleichzeitig der am häufigsten vernachlässigte, weil das gesetzlich verpflichtende Betriebliche Eingliederungsmanagement (BEM) in vielen Mittelständlern nur auf dem Papier existiert. Verschaffen Sie sich aus Ihrer Lohn- oder BGM-Software die Verteilung über diese vier Treiber. Erst diese Verteilung sagt Ihnen, wo Ihr Geld liegt.

3. Messen statt raten: zwei validierte Skalen, die Sie selbst einsetzen können

Sobald Sie etwas verändern, brauchen Sie einen Vorher-Wert, sonst können Sie die Wirkung später nicht beweisen, weder vor sich selbst noch vor dem Betriebsrat. Verlassen Sie sich dabei nicht auf selbstgebastelte Fragebögen, sondern auf wissenschaftlich validierte Instrumente, die Vergleichswerte mitbringen.

Work Ability Index (WAI): Der WAI misst mit sieben Fragen die individuelle Arbeitsfähigkeit auf einer Skala von 7 bis 49 Punkten. Werte unter 28 gelten als kritisch und sagen ein erhöhtes Ausfallrisiko in den Folgejahren voraus. Der WAI ist anonym, in zehn Minuten ausfüllbar und lässt sich jährlich wiederholen, sodass Sie einen echten Trend sehen statt einer Momentaufnahme.

COPSOQ (Copenhagen Psychosocial Questionnaire): Das ist der etablierte Standard zur Messung psychischer Belastung und erfüllt zugleich die gesetzliche Pflicht zur Gefährdungsbeurteilung psychischer Belastung nach Paragraf 5 Arbeitsschutzgesetz. Er erfasst Faktoren wie Arbeitsmenge, Einflussmöglichkeiten, Führungsqualität und Rollenklarheit, jeweils mit deutschen Referenzwerten zum Abgleich.

Wichtig ist die Disziplin: erst messen, dann handeln, dann nach 90 Tagen erneut messen. Genau diese Vorher-Nachher-Logik mit validierten Skalen ist es, die aus 'wir haben etwas gemacht' ein belegbares 'wir haben X Prozentpunkte und Y Euro eingespart' macht. Ohne den Anfangswert verschenken Sie diesen Beweis unwiederbringlich.

4. Der 90-Tage-Fahrplan: von der Zahl zur messbaren Senkung

90 Tage sind realistisch, um die ersten Effekte sichtbar zu machen, wenn Sie diszipliniert in drei Phasen vorgehen. Länger zu planen lähmt, kürzer zu erwarten enttäuscht.

Tag 1 bis 30, Diagnose: Ziehen Sie die Treiber-Verteilung aus Abschnitt 2 und erheben Sie WAI und COPSOQ als Ausgangswert. Parallel prüfen Sie drei Prozesse auf Existenz und Qualität: Rückkehrgespräche nach Krankheit, BEM-Verfahren bei Langzeitfällen und die Urlaubs- und Schichtplanung. In dieser Phase entsteht Ihr Nullpunkt, gegen den am Ende gemessen wird.

Tag 31 bis 60, Eingriff: Setzen Sie an genau ein bis zwei Treibern an, niemals an allen gleichzeitig. Beispiel Muskel-Skelett: ergonomische Begehung der drei belastendsten Arbeitsplätze plus Kurzschulung zu Hebetchnik. Beispiel psychische Belastung: ein strukturiertes Führungstraining zu Belastungsdialogen, denn die direkte Führungskraft ist der stärkste einzelne Einflussfaktor auf den Krankenstand.

Tag 61 bis 90, Verankerung und Nachmessung: Jetzt werden die neuen Routinen Standard, etwa verbindliche Rückkehrgespräche ab dem dritten Fehltag. Am Ende wiederholen Sie WAI und COPSOQ

und stellen die Fehltagel der Vorperiode gegenüber. So entsteht der erste belastbare Wirkungsnachweis. Sie werden sehen: die Diagnose und der Plan sind in 90 Tagen machbar, das konsequente Durchhalten der Routinen über das Quartal hinaus ist die eigentliche Herausforderung.

5. Sofortmaßnahmen, die schon in Wochen wirken

Nicht alles braucht 90 Tage. Vier Hebel wirken erfahrungsgemäß schon innerhalb weniger Wochen und kosten fast nichts außer Konsequenz.

Rückkehrgespräche standardisieren: Ein kurzes, wertschätzendes Gespräch durch die direkte Führungskraft nach jeder Rückkehr aus der Krankheit signalisiert Aufmerksamkeit und senkt nachweislich Kurzzeitfehlzeiten. Wichtig ist der Ton: interessiert, nicht kontrollierend. Geben Sie Ihren Führungskräften einen klaren Gesprächsleitfaden an die Hand, sonst entsteht Misstrauen statt Wirkung.

Präsentismus aktiv bekämpfen: Machen Sie unmissverständlich klar, dass ansteckend Kranke zu Hause bleiben sollen, und ermöglichen Sie das durch flexible Vertretungsregeln. Ein einziger infektiöser Mitarbeiter im Großraumbüro kann eine Welle auslösen, die ein Vielfaches seiner eigenen Fehltagel kostet.

Schicht- und Urlaubsplanung entzerren: Dauerhafte Unterbesetzung erzeugt Überlastung, Überlastung erzeugt Ausfall, Ausfall erzeugt noch mehr Unterbesetzung. Prüfen Sie, ob einzelne Teams strukturell zu knapp geplant sind. Das ist oft der unsichtbare Motor hinter steigenden Quoten.

Führungskräfte ins Boot holen: Kommunizieren Sie die Eurozahl aus Abschnitt 1 offen an Ihre Führungsebene. Sobald Teamleiter verstehen, dass Krankenstand ein bezifferbares Betriebsergebnis ist und kein Schicksal, ändert sich ihr Verhalten. Diese Maßnahmen sind der schnelle Anfang. Damit sie nicht nach drei Monaten wieder einschlafen, brauchen sie einen festen Takt.

6. Warum Prävention ein laufender Prozess ist, kein einmaliges Projekt

Die unbequeme Wahrheit über Krankenstand: Er verhält sich wie Gewicht. Eine einmalige Kur senkt ihn, aber ohne dauerhafte Routine kommt er zurück. Das liegt nicht an mangelndem Willen, sondern an der Natur der Sache. Belegschaften verändern sich, neue Führungskräfte bringen alte Muster mit, Belastungsspitzen verschieben sich, und ohne regelmäßige Messung merken Sie das Abdriften erst, wenn die Quote schon wieder oben ist.

Genau hier scheitern die meisten Eigenversuche. Die Diagnose aus diesem Dokument können Sie selbst stellen, und die Sofortmaßnahmen können Sie selbst starten. Was sich intern selten dauerhaft halten lässt, ist der disziplinierte Takt: das wiederholte Messen mit validierten Skalen, das kontinuierliche Nachsteuern an den richtigen Treibern und das fortlaufende Befähigen der Führungskräfte. Im Tagesgeschäft fällt genau das als Erstes hinten runter.

Deshalb arbeiten wir nicht mit Einmal-Workshops, sondern mit einem laufenden System: ein Vorher-Nachher-Audit mit denselben validierten Skalen, die Sie in Abschnitt 3 kennengelernt haben, sechs aufeinander aufbauende Präventionsseminare über das Jahr verteilt, und eine Wirkungsgarantie, weil wir nur dann überzeugt sind, wenn die Zahl sinkt. Ein DACH-Mandat ist auf diesem Weg in einem

Jahr von 11 auf 7,8 Prozent Krankenstand gekommen, das sind bei einem mittelständischen Betrieb schnell sechsstellige Einsparungen pro Jahr.

Wenn Sie die erste Zahl für Ihren Betrieb gerechnet haben und sehen wollen, wie sie sich dauerhaft halten lässt, sprechen wir das gerne konkret durch. Den Anfang haben Sie mit diesem Dokument bereits gemacht.